Détection, évaluation et prise en charge des séquelles après une encéphalite infectieuse chez l'adulte

Recommandation SPILF

Jeu de diapositives réalisées par le comité des référentiels de la SPILF
9 juillet 2025

Sociétés savantes partenaires

- Société Française de Neurologie (SFN)
- Société Française de Médecine physique Et de Réadaptation (SOFMER)

Terminologie

- **Séquelle** : symptôme survenu au cours ou après une encéphalite aiguë et persistant de manière définitive
- **Déficience** : perte ou diminution d'une fonction organique (*hémiplégie, aphasie*…)
- **Limitation d'activité** : difficulté dans l'exécution d'activités (*s'habiller, se déplacer*…)
- **Restriction de participation** : difficulté d'implication émotionnelle ou intellectuelle dans la vie quotidienne (*travail, loisir*…)

Sont traités dans cette recommandation

- ✓ Les troubles cognitifs
- ✓ Les troubles comportementaux
- ✓ Le retentissement psychoaffectif
- ✓ Les crises épileptiques
- ✓ Les symptômes moteurs, sensitifs et/ou sensoriels
- ✓ Le retentissement fonctionnel
- ✓ La qualité de vie
- ✓ Le handicap invisible

Tests de dépistage (1)

- Séquelles motrices et sensitives : examen clinique
- Efficience cognitive globale : *Montreal Cognitive Assessment* (MoCA)
- Etat psychoaffectif : *Hospital Anxiety and depression scale* (HADS)
- Retentissement fonctionnel : *Instrumental Activities of Daily Living* (IADL)
- Qualité de vie : *Short form 12* (SF12)
- Limitations d'activités : Index de Barthel

Liens en français pour les tests recommandés

- MoCA : https://mocacognition.com/fr/version-papier
- HADS : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2014-11/outil__echelle_had.pdf
- IADL : https://plateforme.santeformapro.com/pdf/iadl.pdf
- SF12 : https://www.snfcp.org/wp-content/uploads/2017/Questionnaires-et-outils/SF12.pdf
- Index de Barthel : https://www.cofemer.fr/cofemer/ckeditorImage/Files/Barthel2.pdf

Tests de dépistage (2)

En cas d'impossibilité de visite présentielle

- French Telephone Interview for Cognitive Status modified (F-TICSm)
- *Montreal Cognitive Assessment* (MoCA) aveugle

Toute anomalie suspectée doit faire orienter vers un spécialiste de l'anomalie retrouvée pour une évaluation approfondie

IRM cérébrale (1)

- Après l'hospitalisation : inutile pour poser l'indication de rééducation et la guider
- Recommandée uniquement si :
  - ✓Non réalisée à la phase aiguë
  - ✓Aggravation neurologique
  - ✓Survenue d'une première crise d'épilepsie
  - ✓Apparition d'un nouveau type de crise épileptique

IRM cérébrale (2)

Si réalisée, elle doit comporter au minimum les séquences :

- 3D-T1 sans et avec injection de gadolinium,
- 3D-T2-FLAIR,
- T2 écho de gradient ou SWI,
- Diffusion,
- Vasculaires 3D-TOF

Epilepsie (1)

- EEG systématique au cours du suivi : **non recommandé**
- Epilepsie traitée avant l'encéphalite : maintenir le traitement et adresser au neurologue référent
- Si initiation d'un traitement antiépileptique : adresser à M3 à un neurologue avec un EEG standard
- **Seul un neurologue peut décider l'arrêt d'un traitement antiépileptique**

Epilepsie (2)

- En cas d'apparition de symptômes évocateurs d'épilepsie focale ou généralisée, à distance de la phase aiguë, il est recommandé de :
  - ✓ Réaliser un EEG standard (avec vidéo) dans les 24 heures
  - ✓ Prescrire un traitement antiépileptique en urgence
  - ✓ Informer le patient du cadre réglementaire (*i.e. conduite automobile*) et de l'hygiène de vie
  - ✓ Consulter un neurologue dans les 15 jours

Place de l'aidant

- Informer et éduquer :
  - patient et aidants
  - sur les séquelles
  - sur leurs conséquences sur la vie quotidienne
- Entretien systématique et périodique avec l'aidant pour identifier les difficultés dans la vie courante
- Accompagnement en lien avec les acteurs médico-sociaux et les associations de patients

Réglementation

- Permis de conduire : information du patient de l'obligation de solliciter l'avis d'un médecin agréé
- Métiers aux conditions d'exercice régies par des arrêtés : avis du médecin du travail avant la reprise
- Activités sportives : informer le patient des risques de certaines activités

La recommandation

Detection, evaluation and management of the sequelae of infectious encephalitis in adults

M. Le Marechal et al.

Infectious diseases now 55 (2025) 105110

DOI: 10.1016/j.idnow.2025.105110